

Melanom · U-urgency + U-scope

exceptional-T1 · T2/T3 gewichtet · SCOPE orthogonal

Form Spec: k1-melanom-urgency · Ontology v1.1

Pins: Welle-06 Melanom §5 copy-through · DE only · keine Form-Meta in der Figur

Dringlichkeit und Zuständigkeit

HP Physio / PT Direktzugang · 10–20 s Scan · gleichtags vs. zeitnah vs. treat+net

112 nur bei vitaler Begleitlage

T1 · Ausnahme

Im Melanom-Screening typischerweise **nicht** primär 112; Ausnahme nur bei vital bedrohlicher Begleitlage (z. B. akute schwere Blutung, Schock). Dann Notruf und Standard-Notfallmanagement; Melanom selbst ist primär onkologisch-dermatologisch zeitkritisch, nicht reanimationspflichtig.

Gleichtags bis zeitnah · ärztlich

Handlung: Therapie an der Läsion stoppen; **keine** destruktiven Maßnahmen; gleichtags Hausarzt/Dermatologie bzw. onkologisch-dermatologische Abklärung; schriftlich „Melanom-DDx / ABCDE-suspekt?“ und Befundbeschreibung mitgeben.

T2

Timing: gleichtags bis zeitnah (bei Blutung/Ulzeration und systemischen Zeichen eher gleichtags).

- Blutende oder ulzerierte unklare Hautläsion
- ABCDE-suspekte oder rasch wachsende pigmentierte Läsion
- B-Symptomatik plus multiple Hautknoten

Zeitnah Dermatologie / Hausarzt

Handlung: Schriftliche Zuweisung Dermatologie/Hausarzt zur Exzisionsabklärung; Patient über Dringlichkeit und Rückkehrgründe informieren.

T3

Timing: zeitnah.

- Neu aufgetretene subunguale Pigmentierung kombiniert mit Nagelwall-Pigmentierung (Verdacht auf Hutchinson-Zeichen)
- Ugly Duckling ohne akute Blutung

Behandeln + Sicherheitsnetz

T4

Handlung: Ohne suspekten Kriterien: MSK-Therapie fortsetzen; bei neu auffälliger Läsion im Verlauf sofort stoppen und zuweisen; auf gesetzliches Hautkrebs-Screening (in DE ab 35 Jahren alle 2 Jahre) hinweisen, ohne Screening zu ersetzen.

GRENZE DER EIGENEN ZUSTÄNDIGKEIT

Keine Melanom-Diagnose, keine Exzision, keine destruktiven Maßnahmen an suspekten Läsionen; endgültige DDx (seborrhoische Keratose vs. Melanom) ist **ärztlich**.